

Острая обтурационная толстокишечная непроходимость как грозное осложнение опухоли толстой кишки в экстренной абдоминальной хирургии у больных пожилого и старческого возраста

Сактаганов К. Е., Мукашев У.И.
Областная больница, г. Петропавловск

Число больных раком толстой кишки неуклонно растет. Неблагоприятным является тот факт, что у большинства больных встречаются осложненные формы данного заболевания (40%-90%). (Трапезников Н.Н., Аксель Е.М., 2001). Проблема неотложной абдоминальной хирургии заключается в том, что значительную часть этих больных составляют пациенты пожилого и старческого возраста и острая кишечная непроходимость опухолевой этиологии нередко является первым проявлением заболевания. Послеоперационная летальность у больных пожилого и старческого возраста с данной патологией составляет 21-44%, а при наличии тяжелых сопутствующих заболеваний достигает 80% (Ханевич М.Д., Шашолин М.А., 2005).

В связи с этим, улучшение результатов хирургического лечения обтурационной толстокишечной непроходимости у больных пожилого и старческого возраста является актуальной проблемой.

Лечение больных с обтурационной кишечной непроходимостью, обусловленное стенозирующей опухолью толстой кишки в сочетании с тяжелыми соматическими заболеваниями создает определенные трудности в принятии оптимальной лечебной тактики.

Нами анализированы результаты лечения 46 больных старших возрастных групп за период 2005-2009гг, подвергнутых экстренному оперативному вмешательству. Мужчин было 16(35%), женщин – 30(65%), у 80% пациентов возраст составлял старше 75 лет.

Во время оперативного вмешательства выявлены: стенозирующие опухоли правой половины – 12,3%, поперечно-ободочной кишки- 24,7%, левой половины толстой кишки- 49,9%, ректосигмоидного отдела -13,9%.

Результаты и обсуждение.

Все больные поступали в тяжелом состоянии с декомпенсированной формой кишечной непроходимости. После предоперационной подготовки все больные оперированы. Немаловажную роль в исходе заболевания играет двойной характер интоксикации, обусловленный основным раковым процессом и переполнением толстого кишечника с вовлечением в процесс непроходимости тонкой кишки. В этой связи важным этапом в оперативном лечении опухолевой толстокишечной непроходимости в стадии декомпенсации является адекватная декомпрессия тонкой кишки путем назоинтестинальной интраоперационной интубации тонкого

кишечника и предварительной цекостомии.

Больным выполнены операции:

1. При левосторонней локализации опухоли в большинстве случаев (92%) выполнены обструктивные резекции толстой кишки с опухолью и выведением одноствольной колостомы (Операция Гартмана).

2. При локализации опухоли в правой половине (слепая, восходящая) 64% удалось выполнить правостороннюю гемиколэктомию с выведением концевой энтеростомы. В остальных случаях вынуждены были ограничиться цекостомией или концевой энтеростомией.

3. При стенозирующих опухолях поперечно-ободочной кишки выполнены резекции участка кишки вместе с опухолью с выведением колостомы.

В послеоперационном периоде проводили интенсивное лечение, направленное на восстановление белкового баланса, КЩР, поддержку жизненно важных органов.

Анализ результатов лечения у представленной группы больных показал, что послеоперационная летальность у больных пожилого и старческого возраста с острой толстокишечной непроходимостью опухолевого составила 13,6%.

Заключение

Приведенные данные свидетельствуют, что в большинстве случаев при опухолевой толстокишечной непроходимости удаление опухолевого образования при первичной операции способствует улучшению результатов хирургического лечения обтурационной кишечной непроходимости опухолевого генеза у больных пожилого возраста, а также несомненно положительно отражается на продолжительности жизни данной категории больных.

Список литературы

1. Трапезников Н.Н., Аксель Е.М. Статистика злокачественных новообразований в России и странах СНГ. М.: РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, 2001.
2. Ерюхин И.А., Петров В.П. Кишечная непроходимость. – СПб.: Питер, 1999.
3. Ханевич М.Д., Шашолин М.А. Колоректальный рак., Петрозаводск, 2003.
4. Ерюхин И.А., Зубарев П.Н. Декомпрессия тонкой кишки при острой непроходимости кишечника//Хирургия . 1998 №11, с. 15-19.